Клинические рекомендации

Хронический тонзиллит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.2** — Хронический фарингит **J35.0** — Хронический тонзиллит **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов **J35.9** — Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/683_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Местные признаки 2

2.3 Классификация Солдатова 3

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна 3

2.5 Жалобы и анамнез 4

3. Диагностика 4

3.1 Фарингоскопия 4

3.2 Анализы крови и мочи 5

3.3 Антистрептолизин-О 5

3.4 Исследование на БГСА 5

4. Лечение 5

4.1 При обострении (ангине) 5

4.2 Системные антибиотики 6

4.3 Межрецидивный период: консервативное лечение 6

4.4 Хирургическое лечение 6

4.5 Послеоперационное ведение 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Диагноз устанавливается на основании данных фарингоскопии: решающее значение имеют местные признаки хронического воспаления миндалин, наиболее важным из которых является жидкий гной в лакунах. Размер миндалин диагностического значения не имеет.
- В период острого воспаления глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливают: достоверная оценка его признаков возможна только **через 3–4 недели** после купирования острого процесса.
- По классификации Солдатова выделяют компенсированную и декомпенсированную формы; форму определяют по анамнезу **за последние три года**.
- Консервативное лечение назначают курсами в межрецидивный период:
  1. компенсированная форма: **2 раза в год**, весной и осенью;
  2. рецидивирующие ангины: **до 4 раз в год**, за 1–1,5 месяца до ожидаемого обострения.
- Показания к тонзиллэктомии:
  1. любой вид декомпенсации;
  2. рецидивирующие ангины при неэффективности противорецидивного лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический тонзиллит является инфекционно-аллергическим заболеванием всего организма с местными проявлениями в виде стойкого воспаления нёбных миндалин с альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

2.2 Местные признаки

Пять групп местных признаков

1. гиперемия и валикообразное утолщение краёв нёбных дужек;
2. рубцовые спайки между миндалинами и нёбными дужками;
3. разрыхлённые или, напротив, рубцово изменённые и уплотнённые миндалины;
4. казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах;
5. увеличение регионарных лимфатических узлов.

1. признак Гизе: гиперемия краёв передних нёбных дужек;
2. признак Зака: отёк в месте соединения передних и задних дужек;
3. признак Преображенского: валикообразное утолщение краёв верхних отделов передних и задних дужек.

2.3 Классификация Солдатова

Компенсированная форма

1. местные признаки;
2. общие симптомы нерезко выражены или отсутствуют.

Декомпенсированная форма: местные признаки и хотя бы один вид декомпенсации

1. рецидивы ангин;
2. паратонзиллит или паратонзиллярный абсцесс;
3. тонзиллогенная интоксикация: длительный субфебрилитет, недомогание, снижение трудоспособности при отсутствии другой причины;
4. тонзиллогенные функциональные нарушения внутренних органов;
5. заболевания органов, патогенетически связанные с тонзиллитом.

Форму определяют по данным анамнеза **за последние три года**.

2.4 Классификация Преображенского — Пальчуна

Простая форма

1. только местные признаки;
2. в подавляющем большинстве случаев в анамнезе ангины.

Токсико-аллергическая форма I степени (признаки периодические)

1. субфебрилитет;
2. слабость, быстрая утомляемость;
3. боли в суставах;
4. увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов;
5. непостоянные функциональные нарушения со стороны сердца;
6. нестойкие отклонения лабораторных показателей.

Токсико-аллергическая форма II степени

1. функциональные нарушения сердечной деятельности, подтверждённые электрокардиографией (ЭКГ);
2. сердцебиение и нарушения ритма;
3. боли в области сердца и в суставах как во время ангины, так и вне её;
4. функциональные нарушения почек, печени, суставов и сосудов.

Сопряжённые заболевания

1. паратонзиллярный абсцесс;
2. парафарингит;
3. тонзиллогенный сепсис;
4. ревматизм;
5. артрит;
6. приобретённые пороки сердца;
7. гломерулонефрит.

Описано около 100 заболеваний, патогенетически связанных с хроническим тонзиллитом; наиболее часто поражаются сердце, суставы, почки, эндокринная система и кожа. В сложных случаях тактика ведения определяется совместно с профильным специалистом.

2.5 Жалобы и анамнез

Местные жалобы

1. незначительная боль;
2. першение;
3. ощущение инородного тела в горле;
4. периодический сухой кашель;
5. неприятный запах изо рта.

Жалобы неспецифичны: встречаются также при хроническом фарингите, заболеваниях гортани, полости рта и зубов; у части пациентов жалоб нет.

Общие жалобы при декомпенсированной форме

1. длительное недомогание;
2. снижение работоспособности;
3. затяжной субфебрилитет.

Эти жалобы неспецифичны и требуют обследования для исключения других причин.

У детей и взрослых, особенно часто и длительно болеющих, уточняются местные и общие жалобы, а также частота ангин. Многие авторы считают ангины в анамнезе наиболее достоверным признаком хронического тонзиллита, однако сведения о них должны быть подтверждены.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании:

1. анамнеза: ангины, длительная утомляемость, субфебрилитет, регионарный лимфаденит, сопряжённые с тонзиллитом заболевания;
2. физикального обследования;
3. лабораторных данных;
4. фарингоскопии.

3.1 Фарингоскопия

Показания

1. дети и взрослые: исключение острого тонзиллита и выявление местных признаков хронического тонзиллита.

При остром воспалении глотки диагноз хронического тонзиллита не устанавливают: достоверная оценка признаков возможна только **через 3–4 недели**.

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал, фарингоскопию и эпифарингоскопию.

Диагностические признаки

1. решающее значение имеют фарингоскопические признаки;
2. наиболее важный признак: жидкий гной в лакунах, нередко с неприятным запахом;
3. увеличение регионарных лимфатических узлов может быть обусловлено и другими воспалительными процессами головы и шеи;
4. размер миндалин диагностического значения не имеет.

Осмотр выполняют при ярком направленном освещении с использованием двух шпателей, при необходимости зонда. За 20–30 минут до осмотра пациенту не рекомендуется принимать пищу, горячие, холодные и газированные напитки, курить и разговаривать на холоде, что позволяет избежать транзиторной гиперемии. Надавливание вторым шпателем на нёбную дужку позволяет выявить содержимое лакун и спайки.

3.2 Анализы крови и мочи

Показания

1. выявление сопряжённых с тонзиллитом заболеваний: общий анализ крови и мочи, С-реактивный белок (СРБ), ревматоидный фактор.

3.3 Антистрептолизин-О

Показания

1. дифференциальная диагностика активной стрептококковой инфекции и носительства.

Высокий уровень АСЛ-О при отсутствии стрептококка в посевах свидетельствует о возможной внутриклеточной персистенции и рассматривается как подтверждение декомпенсации. Однако высокий уровень АСЛ-О без симптомов со стороны миндалин сам по себе не является показанием к лечению.

Возраст	Норма АСЛ-О, МЕ/мл
До 7 лет	до 100
7–14 лет	150–200
С 14 лет	до 250

3.4 Исследование на БГСА

Показания

1. бактериологическое исследование отделяемого с нёбных миндалин на бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА) или экспресс-тест.

Анализы крови и мочи, посевы и цитологическое исследование содержимого лакун для постановки диагноза практически не имеют значения. Они необходимы для уточнения формы заболевания, роли микрофлоры, связи с заболеваниями других органов и оценки эффективности лечения.

Лазерная допплеровская флоуметрия, ультразвуковое исследование (УЗИ) и другие дополнительные методы пока не получили распространения, доказательства их эффективности отсутствуют.

---

4. Лечение

Перед началом любого лечения необходимы осмотр и при необходимости санация зубов, околоносовых пазух и носоглотки.

4.1 При обострении (ангине)

Тактика при ангине определяется рекомендациями по острому тонзиллофарингиту, при паратонзиллите и абсцессе рекомендациями по этим заболеваниям. Курсы лечения хронического тонзиллита назначают в межрецидивный период.

Взрослым при обострении рекомендованы нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для местного применения.

4.2 Системные антибиотики

При обострении, выделении стрептококка или признаках осложнений

1. системные антибиотики; препараты выбора: пенициллины.

Вне обострения: при функциональных нарушениях внутренних органов, отрицательных посевах на БГСА и стойко повышенном АСЛ-О

1. 14-членные макролиды курсом **до 2 недель**.

Целесообразность антибактериальной терапии в межрецидивный период остаётся дискутабельной, поэтому решение принимается индивидуально на основании объективных данных, динамики симптомов и лабораторных показателей.

При подтверждённой грибковой этиологии используют противогрибковые препараты внутрь с учётом чувствительности.

4.3 Межрецидивный период: консервативное лечение

Форма	Курсы консервативного лечения
Компенсированная, простая	2 раза в год, весной и осенью
Декомпенсация в виде рецидивов ангин, токсико-аллергическая форма I степени	до 4 курсов в год, за 1–1,5 месяца до ожидаемой ангины
Другие виды декомпенсации, токсико-аллергическая форма II степени	только при противопоказаниях к операции

1. Обязательное условие эффективности: дренирование лакун и очищение складок и карманов от экссудата и детрита.
2. Промывание лакун миндалин курсом **10 процедур** ежедневно или через день; не ранее чем **через 2–3 недели** после острого воспаления.
3. Антисептики в виде полосканий, инсуффляций, ингаляций и таблеток для рассасывания.
4. Топические бактериальные лизаты в таблетках для рассасывания: уменьшают частоту и продолжительность обострений.
5. Растительные препараты курсами для снижения частоты ангин: корень алтея, цветки ромашки, трава тысячелистника, кора дуба, трава хвоща, корень одуванчика.
6. Консультация физиотерапевта в период ремиссии; физиотерапии предшествует курс промываний.

Для промывания используются стерильный раствор натрия хлорида или растворы антисептиков с соблюдением дозировок и возрастных ограничений и с учётом возможной аллергии на препараты йода. Смазывание миндалин курсом 10–15 процедур выполняют отдельно или непосредственно после промывания.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста от промывания и смазывания миндалин следует воздержаться в связи с риском рефлекторного ларингоспазма.

4.4 Хирургическое лечение

Двусторонняя тонзиллэктомия выполняется в межрецидивный период для радикального устранения очага инфекции.

Показания к тонзиллэктомии

Основание	Показания к тонзиллэктомии
Классификация Солдатова	1. любой вид декомпенсации, кроме рецидивов ангин без проведённого противорецидивного лечения; 2. рецидивы ангин: при неэффективности консервативного лечения с сохранением ангин или появлением другого вида декомпенсации.
Классификация Преображенского — Пальчуна	1. токсико-аллергическая форма II степени; 2. простая форма и токсико-аллергическая форма I степени при неэффективности **2–3 тщательно проведённых курсов** консервативного лечения в год.
Дети	1. частые стрептококковые ангины: **не менее 7** за последний год, **не менее 5 в год** за последние 2 года или **не менее 3 в год** за последние 3 года; 2. два и более паратонзиллярных абсцесса (в ряде случаев и после одного); 3. заключение профильных специалистов, если тонзиллэктомия необходима как этап лечения сопутствующего заболевания.
Критерии Paradise	1. 7 эпизодов боли в горле за год, 5 эпизодов в каждом из двух лет или 3 эпизода в каждом из трёх лет. Эпизод: боль в горле и хотя бы один признак: температура тела 38,3 °C и выше, экссудат на миндалинах, увеличение шейных лимфатических узлов более 2 см с болезненностью, БГСА в посеве или положительный экспресс-тест.

Абсолютные противопоказания

1. заболевания крови: гемофилия, лейкозы, геморрагические диатезы;
2. аномалии сосудов глотки (пульсация боковой стенки);
3. тяжёлая сердечная недостаточность II–III степени;
4. выраженная почечная недостаточность;
5. тяжёлый сахарный диабет с кетонурией;
6. тяжёлые заболевания печени;
7. тяжёлые нервно-психические заболевания;
8. злокачественные новообразования;
9. активный туберкулёз.

Относительные противопоказания

1. острые инфекционные заболевания и период 3–4 недель после них;
2. острые воспалительные заболевания и обострения хронических, в том числе ЛОР-органов;
3. эпидемии гриппа;
4. менструация;
5. неактивный туберкулёз;
6. преходящая тромбоцитопения;
7. сахарный диабет нетяжёлого течения;
8. кариозные зубы.

Наиболее частое осложнение: кровотечение из тонзиллярной ниши во время операции или **в первые 5–7 дней**, возможно и **на 8–15-е сутки**. Поэтому первые 5–7 дней пациент находится в стационаре, а после выписки ещё 5–7 дней наблюдается в поликлинике с освобождением от работы.

4.5 Послеоперационное ведение

1. в первые сутки постельный и голосовой режим; через несколько часов после операции разрешается несколько глотков воды;
2. в последующие дни щадящий режим, пища жидкая или протёртая, не горячая и не холодная;
3. местные и системные анальгетики;
4. профилактика обострения сопутствующих заболеваний.

Для обезболивания и уменьшения воспаления используют НПВП.

После тонзиллэктомии в течение месяца рекомендуются ограничение физической нагрузки и соблюдение режима сна и отдыха.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Компенсированная форма: курсы лечения **2 раза в год**. Если **за 3 года** не было ангин и других признаков декомпенсации, пациента снимают с диспансерного учёта.

Декомпенсация в виде рецидивов ангин: курсы лечения **3–4 раза в год**. При неэффективности лечения **в течение года**, осложнённом течении ангин или появлении другого вида декомпенсации пациента направляют на хирургическое лечение.

После тонзиллэктомии диспансерное наблюдение продолжается **6 месяцев**.

Для профилактики рецидивов и восстановления нормальной микрофлоры ротоглотки применяются биологически активные добавки (БАД), содержащие естественные бактерии ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

Риск развития хронического тонзиллита повышают несбалансированное питание (особенно дефицит витаминов A, B, E), переутомление, неудовлетворительные гигиенические условия жилья и рабочего места, загрязнённый воздух, курение, в том числе пассивное, заболевания зубов, полости носа и околоносовых пазух, частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и их нерациональное лечение.

Лечение, как правило, осуществляет оториноларинголог в амбулаторных условиях.

Показания к госпитализации в хирургическое отделение

1. неэффективность лечения;
2. подозрение на гнойное осложнение: паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит;
3. подозрение на новообразование;
4. необходимость хирургического лечения.

Тонзиллэктомию выполняют в оториноларингологическом отделении в плановом порядке; при неосложнённом послеоперационном периоде пациента выписывают **на 5–7-е сутки**.

Переход тонзиллита в декомпенсированную форму чаще наблюдается при иммунодефиците (врождённом, на фоне приёма иммунодепрессантов и цитостатиков, при ВИЧ-инфекции). Аутоиммунные осложнения более вероятны при стрептококковой этиологии тонзиллита и ревматической лихорадке у пациента или ближайших родственников.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический тонзиллит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	683_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 1.4 указан код J31.1 «Хронический назофарингит», тогда как в карточке рубрикатора приведён J31.2 «Хронический фарингит». На сайте указан код из текста КР.